



Protocolo de tratamiento de las adicciones comportamentales

R.M. Hodann-Caudevilla^{a,*}, M. Roncero Rodríguez^a, R.M. Molina-Ruiz^b y M. Pérez Lombardo^b

^aCentro AdCom. Instituto de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. España. ^bInstituto de Psiquiatría y Salud Mental. Hospital Clínico San Carlos. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Adicciones comportamentales
- Adicciones sin sustancia
- Juego patológico
- Adicción a los videojuegos
- Algoritmo de tratamiento

Keywords:

- Behavioral addictions
- Non-substance addiction
- Compulsive gambling
- Video game addiction
- Treatment algorithm

Resumen

Las adicciones comportamentales engloban un grupo diverso de trastornos caracterizados por la implicación repetida y persistente en conductas placenteras que no implican el consumo de sustancias. El presente protocolo se centra en la comprensión de las características clínicas, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de estas adicciones, haciendo hincapié en la importancia de un abordaje integral y personalizado. Se destacan las principales estrategias de tratamiento, incluidas las intervenciones psicológicas y psicofarmacológicas.

Abstract

Treatment protocol for behavioral addictions

Behavioral addictions encompass a diverse group of disorders characterized by repeated and persistent participation in pleasurable behaviors that do not involve consuming substances. This protocol focuses on understanding the clinical characteristics, evaluation, diagnosis, and treatment of these addictions, with a special focus on the importance of a comprehensive, personalized approach. The main treatment strategies are highlighted, including psychological and psychopharmacological interventions.

Introducción

Las adicciones comportamentales, también conocidas como adicciones sin sustancia, son un grupo heterogéneo de trastornos que se caracterizan por la implicación repetida y persistente en una o más conductas gratificantes (a veces denominadas reforzadores naturales), no relacionadas con el consumo de sustancias¹. Dichas conductas se realizan de forma compulsiva a pesar de las consecuencias negativas para el bienestar físico, mental, social o económico de la persona.

Las adicciones comportamentales comparten características clave con las adicciones a sustancias como la búsqueda de la conducta adictiva con el propósito de modificar el estado de ánimo, el desarrollo de tolerancia, la experiencia de síndrome de abstinencia y la presencia de un curso crónico

con recaídas². Asimismo, al igual que en las adicciones a sustancias, en las adicciones comportamentales se tiende a dar una pérdida progresiva del control sobre la conducta que, con frecuencia, se asocia con la aparición de consecuencias adversas sobre áreas relevantes de la vida de la persona (problemas legales, financieros o matrimoniales)³. Suele ser la toma de conciencia de estas consecuencias adversas lo que lleva a la persona afectada a buscar ayuda profesional.

Otro aspecto relevante de las adicciones comportamentales es la alta frecuencia con la que se presentan junto a otras patologías psiquiátricas, fenómeno al cual se le suele dar el nombre de «comorbilidad» o «patología dual». Por ejemplo, en un estudio realizado por Jaureguí et al.⁴ se encontró que los jugadores patológicos mostraban mayores niveles de ansiedad, depresión y abuso de sustancias en comparación con personas sin problemas de juego. En adolescentes con adicción a los videojuegos, también se ha informado de niveles elevados de depresión y ansiedad⁵. Se debe prestar atención a este solapamiento, dado que puede complicar el tratamiento de las adicciones comportamentales, lo que subraya la ne-

*Correspondencia
Correo electrónico: rhodann@ucm.es

cesidad de incluir en la evaluación la exploración de las posibles patologías psiquiátricas comórbidas.

En la actualidad, tanto la Asociación Americana de Psiquiatría (APA)⁶ como la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁷ reconocen las adicciones comportamentales, empleando para ello criterios clínicos similares. El juego patológico, o trastorno del juego, está clasificado como un trastorno adictivo por ambos organismos. Además, la OMS ha identificado la adicción a los videojuegos, denominándola trastorno por uso de videojuegos. Otras conductas como la implicación excesiva en conductas sexuales (consumo compulsivo de pornografía en Internet), el abuso de las redes sociales en línea o las compras compulsivas aún no se han considerado oficialmente trastornos adictivos, pero la evidencia disponible sugiere que pueden generar patrones adictivos y acarrear problemas graves⁸.

Aunque la investigación sobre la prevalencia de las adicciones comportamentales sigue en curso, los estudios existentes informan de tasas alarmantemente elevadas. Por ejemplo, un metaanálisis reciente de Alimoradi et al.⁹ reveló una prevalencia global del 11,1% para las adicciones comportamentales, independientemente del tipo. Asimismo, los estudios disponibles tienden a coincidir en que la prevalencia está aumentando de manera gradual con el paso del tiempo.

Características clínicas

Como ya se ha mencionado, las adicciones comportamentales presentan múltiples aspectos en común con las adicciones a sustancias, incluyendo fenómenos como la tolerancia, el síndrome de abstinencia y las ansias de consumo (a las cuales se alude con el anglicismo «*craving*»). Ahora bien, las adicciones comportamentales también tienen algunas características clínicas únicas y específicas de cada conducta en particular. Mark Griffiths¹⁰, investigador de referencia en el campo de las adicciones comportamentales, desarrolló un modelo de componentes que proporciona un marco útil para comprender estas características. Los componentes del modelo de Griffiths son los siguientes¹⁰:

Saliencia

Se refiere a que la conducta se convierte en la actividad más importante en la vida de la persona, llegando a dominar su pensamiento, sentimientos y comportamiento.

Modificación del estado de ánimo

Hace referencia a la experiencia subjetiva placentera que las personas obtienen como consecuencia de implicarse en la conducta (es decir, el llamado «subidón», el «escape» o la «anestesia»).

Tolerancia

Necesidad de incrementar el tiempo dedicado a la conducta o su intensidad para conseguir el nivel de placer esperado.

Síntomas de abstinencia

Síntomas emocionales y/o físicos desagradables que la persona experimenta cuando no puede realizar la conducta.

Conflicto

Conflictos que surgen entre la persona y su entorno cotidiano (con los seres queridos) o consigo misma (ideación de culpa o vergüenza) derivados de la implicación excesiva en la conducta.

Recaída

Tendencia a volver a los patrones de actividad anteriores (la implicación excesiva en la conducta) después de un período de abstinencia o autocontrol.

Cabe destacar que, tal y como señala Griffiths¹⁰, no resulta necesario que estén presentes todos los componentes del modelo para realizar un diagnóstico de adicción conductual, aunque sí resulta conveniente tenerlos en cuenta mientras se realiza la evaluación.

Evaluación y diagnóstico

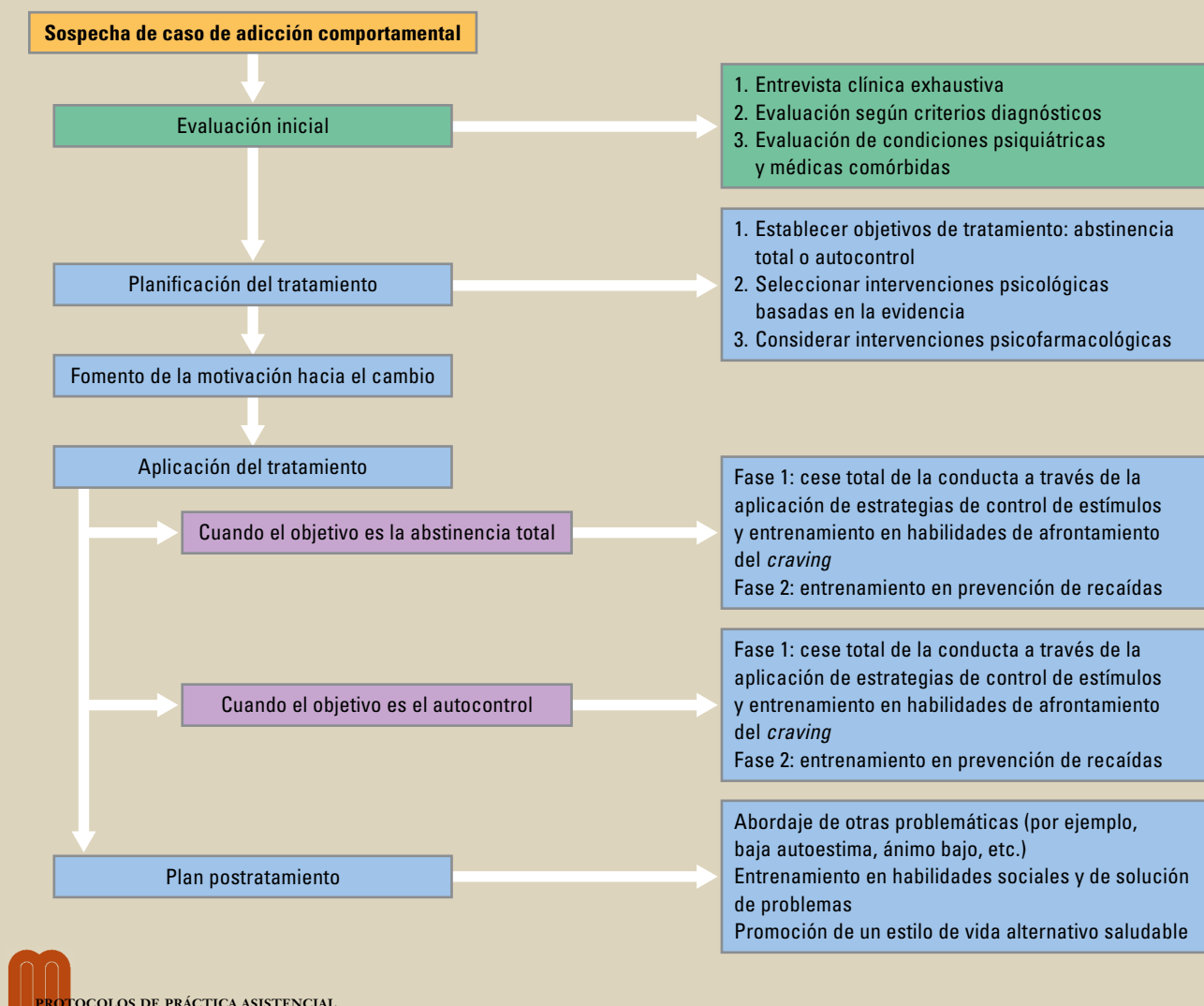
El diseño y la aplicación de intervenciones eficaces para el tratamiento de las adicciones comportamentales requiere que vayan precedidas de procesos de evaluación y diagnóstico lo más precisos y exhaustivos posibles. En dichos procesos se deben tener en cuenta, además, las necesidades y circunstancias únicas de cada persona para adecuar el posterior plan de tratamiento y que este tenga las mayores posibilidades de éxito.

Instrumentos de detección

Las herramientas de cribado desempeñan un papel fundamental en la identificación de la presencia de las adicciones comportamentales. En su mayoría, estas herramientas consisten en escalas psicométricas que pueden ser autoadministradas o aplicadas por un profesional. Entre ellas, encontramos desde medidas específicas dirigidas a una adicción concreta (por ejemplo, la escala NODS de Becoña¹¹ para el juego patológico) hasta sistemas de evaluación más amplios como el MULTICAGE CAD-4 de Pedrero-Pérez¹². Estas herramientas también permiten evaluar la gravedad de la adicción y monitorizar el progreso del paciente, ayudando así en la toma de decisiones terapéuticas.

Entrevista clínica

Una entrevista clínica implica una conversación, con mayor o menor grado de estructuración, entre un profesional de la salud mental y un paciente con una adicción conductual.



PROTOCOLOS DE PRÁCTICA ASISTENCIAL

Fig. 1. Algoritmo para el abordaje de las adicciones comportamentales.

Esta conversación permite recoger datos relevantes sobre la historia del paciente, incluidos los síntomas actuales, el grado de afectación y el nivel de funcionamiento general. También sirve para recoger información útil sobre el contexto del paciente, en el cual se pueden identificar factores de riesgo o protección frente a la adicción, y determinar el curso del tratamiento apropiado. Por lo tanto, la entrevista clínica resulta una herramienta fundamental a lo largo de todo el proceso terapéutico, desde la evaluación hasta el final del tratamiento.

Criterios diagnósticos

Para las personas que presentan adicción al juego o a los videojuegos, los diagnósticos pueden basarse en los sistemas de clasificación DSM-5⁶ y CIE-11⁷. Los criterios diagnósticos de ambos manuales permiten determinar si la conducta que presenta la persona constituye, o no, un diagnóstico psiquiátrico.

Evaluación de la comorbilidad

Como se ha señalado anteriormente, las personas con adicciones comportamentales presentan con frecuencia otros trastornos psiquiátricos concurrentes¹³. Estos trastornos pueden alterar de manera significativa el funcionamiento general de la persona y, en última instancia, reducir de manera notable su nivel de calidad de vida. Por ende, para desarrollar un plan de tratamiento efectivo se debe realizar una evaluación precisa de la posible comorbilidad.

Abordaje de las adicciones comportamentales

Debido a su naturaleza compleja, las adicciones comportamentales requieren tratamientos integrales que profundicen en las causas subyacentes de la adicción y atiendan al mismo tiempo a las necesidades y circunstancias únicas del individuo. Como se expone a continuación, las opciones de tratamiento incluyen enfoques tanto psicológicos como psicofarmacológicos (fig. 1).

Abordaje psicológico

Las intervenciones psicológicas constituyen la base del tratamiento de las adicciones comportamentales y, en general, abordan los distintos aspectos cognitivos, emocionales y conductuales que contribuyen al desarrollo de la adicción y a su mantenimiento. Pueden tener como objetivo la abstinencia total (es decir, el cese total de la ejecución de la conducta) o el autocontrol (reducir la implicación en la conducta hasta lograr un nivel no perjudicial)¹⁴. El objetivo elegido dependerá de la adicción específica, la gravedad del trastorno y de las preferencias que tenga la persona. En cualquier caso, el fin último del tratamiento psicológico es el de dotar a la persona de estrategias de afrontamiento saludables, mejorar su capacidad de autorregulación y promover la recuperación a largo plazo.

Actualmente, la terapia cognitivo conductual (TCC) es el tratamiento psicológico con mayor apoyo empírico para las adicciones conductuales¹⁵. La TCC se centra en ayudar a las personas a identificar y desafiar los pensamientos y creencias negativos o dañinos, y a desarrollar formas de pensar y comportarse más adaptativas. Los componentes de la TCC para las adicciones conductuales incluyen:

Psicoeducación

Se emplea para mejorar la comprensión de la adicción, sus causas, consecuencias y estrategias de tratamiento.

Intervenciones conductuales

Se aplican estrategias diseñadas específicamente para modificar los comportamientos no saludables (el control de estímulos, la exposición con prevención de respuesta o el entrenamiento en habilidades de afrontamiento y la resolución de problemas).

Reestructuración cognitiva

Consiste en identificar y modificar las creencias irracionales y otra clase de distorsiones cognitivas que desencadenan o mantienen las conductas adictivas.

Prevención de las recaídas

Consiste en dotar a las personas de herramientas y técnicas para prevenir las recaídas, como la identificación de situaciones de alto riesgo, el desarrollo de habilidades de afrontamiento y el establecimiento de una red social de apoyo.

A menudo la TCC se combina con otros enfoques, como la entrevista motivacional, las intervenciones basadas en la atención plena o la terapia familiar o de pareja. Además, el tratamiento psicológico puede administrarse individualmente o en grupo, en función de las necesidades y preferencias específicas de la persona.

Abordaje psicofarmacológico

Aunque el tratamiento psicológico sigue siendo el tratamiento principal de las adicciones comportamentales, las intervenciones psicofarmacológicas pueden complementar el tratamiento abordando síntomas específicos o los trastornos

psiquiátricos concurrentes. La elección del fármaco dependerá del estado clínico del paciente y de los trastornos comórbidos¹⁶. Por ejemplo, pueden prescribirse antidepresivos para la depresión comórbida, mientras que los estabilizadores del estado de ánimo o los antipsicóticos atípicos pueden considerarse para personas con diagnóstico de trastorno bipolar o problemas graves del control de los impulsos. El seguimiento meticuloso y los ajustes de la medicación resultarán esenciales para maximizar la eficacia y minimizar los posibles efectos secundarios. La colaboración entre el médico prescriptor, el psicólogo y el paciente también resulta crucial para lograr resultados satisfactorios tanto en el tratamiento de la adicción como en el tratamiento de la comorbilidad.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

- Shaffer HJ, Shaffer PM. Behavioral addiction. En: Friedman HS, editor. Encyclopedia of mental health [Internet]. 2ª ed. Oxford: Academic Press; 2016. p. 135-42. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978012397045900077X>
- Rosenberg KP, Feder LC. An introduction to behavioral addictions. En: Rosenberg KP, Curtiss L, eds. Behavioral addictions: Criteria, evidence, and treatment. Elsevier; 2014. p. 1-17.
- Banz BC, Yip SW, Yau YHC, Potenza MN. Behavioral addictions in addiction medicine: from mechanisms to practical considerations. *Prog Brain Res*. 2016;223:311-28.
- Jauregui P, Estévez A, Urbiola I. Pathological gambling and associated drug and alcohol abuse, emotion regulation, and anxious-depressive symptomatology. *J Behav Addict*. 2016;5(2):251-60.
- Wang Y, Liu B, Zhang L, Zhang P. Anxiety, depression, and stress are associated with internet gaming disorder during COVID-19: Fear of missing out as a mediator. *Front Psychiatry*. 2022;13:827519.
- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition: DSM-5. 5ª ed. Washington, D.C.: American Psychiatric Publishing; 2013. p. 991.
- Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional de Enfermedades, 11ª revisión [Internet]. 2019 [Consultado 28 Jul 2022]. Disponible en: <https://icd.who.int/es>
- Petry NM, Zajac K, Ginley MK. Behavioral addictions as mental disorders: To be or not to be? *Annu Rev Clin Psychol*. 2018;14:399-423.

9. Alimoradi Z, Lotfi A, Lin CY, Griffiths MD, Pakpour AH. Estimation of behavioral addiction prevalence during COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Curr Addict Rep*. 2022;9(4):486-517.
10. ●● Griffiths M. A 'components' model of addiction within a biopsychosocial framework. *J Substance Use*. 2005;10(4):191-7.
11. Becoña E. Prevalencia del juego patológico en Galicia mediante el NODS. ¿Descenso de la prevalencia o mejor evaluación del trastorno? *Adicciones*. 2004;16(3):173-84.
12. Pedrero-Pérez EJ, Rodríguez-Monje MT, Gallardo-Alonso F, Fernández-Girón M, Pérez-López M, Chicharro-Romero J. Validación de un instrumento para la detección de trastornos de control de impulsos y adicciones: el MULTICAGE CAD-4. *Trastornos Adictivos*. 2007;9(4):269-79.
13. ●● Starcevic V, Khazaal Y. Relationships between behavioural addictions and psychiatric disorders: What is known and what is yet to be learned? *Front Psychiatry*. 2017;8:53.
14. Chóliz M, Marco C. Adicción a Internet y redes sociales: tratamiento psicológico. Madrid: Alianza; 2012. p. 224.
15. ●● Goslar M, Leibetseder M, Muench HM, Hofmann SG, Laireiter AR. Treatments for internet addiction, sex addiction and compulsive buying: A meta-analysis. *J Behavioral Addictions*. 2020;9(1):14-43.
16. ● Dowling NA, Merkouris SS, Lorains FK. Interventions for comorbid problem gambling and psychiatric disorders: Advancing a developing field of research. *Addictive Behaviors*. 2016;58:21-30.